

Un CT cérébral natif a été réalisé: quel est votre diagnostic ?



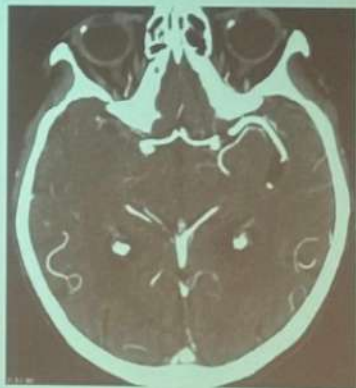
- a) Hématome épidural avec effet de masse
- b) Hématome épidural sans effet de masse
- c) Hématome sous dural avec effet de masse
- d) Hématome sous dural sans effet de masse
- e) Hématome intraparenchymateux

30 ans, chute à vélo
Brève perte de connaissance
Céphalées à l'admission

Quelle imagerie demandez-vous en urgence?

- a) RX du crâne
- b) CT cérébral natif
- c) CT cérébral injecté
- d) IRM cérébrale native
- e) IRM cérébrale injectée

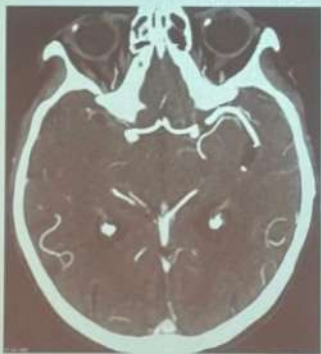
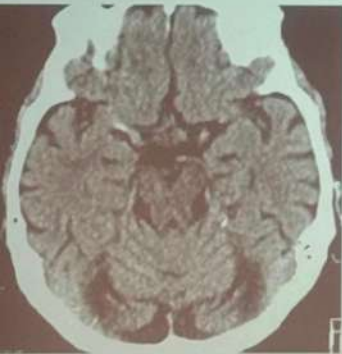
89 ans, dysarthrie, hémiparésie gauche



Les images, obtenues en urgence, correspondent à:

- a) un examen CT cerebral natif + examen IRM avec contraste
- b) un examen IRM natif + examen IRM avec contraste
- c) un examen CT natif + artériographie cérébrale
- d) un examen CT natif + examen CT avec contraste

89 ans, dysarthrie, hémiparésie gauche



L'anomalie se situe au niveau de:

- a) l'artère cérébrale moyenne gauche
- b) le mésencéphale
- c) l'artère cérébrale moyenne droite
- d) le sinus veineux
- e) le cervelet



Radiographies des mains

Les anomalies correspondent à la pathologie suivante:

- a) Goutte
- b) Chondrocalcinose
- c) Polyarthrite rhumatoïde
- d) Arthrite psoriasique



Radiographie du bassin

Quelles anomalies identifiez-vous ?

Plusieurs réponses possibles

- a) Arthrose coxo-femorale bilatérale
- b) Erosions sacro-iliaques bilatérales
- c) Erosions sacro-iliaques droite
- d) Ankylose sacro-iliaque gauche
- e) Ankylose sacro-iliaque droite



Une radiographie du genou a été réalisée



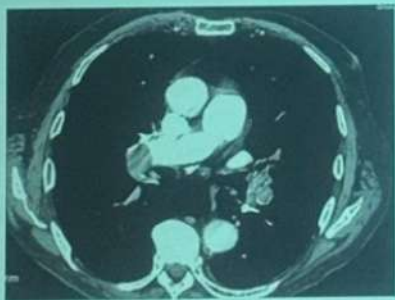
Quel est votre diagnostic?

- a) Arthrose fémoro-patellaire
- b) Ostéomyélite
- c) Arthrite du genou
- d) Tumeur osseuse

55 ans, retour de vacances en voiture, dyspnée

Quel examen demandez-vous en urgence ?

- a) Une radiographie du thorax
- b) Un CT du thorax natif (sans injection de contraste)
- c) Un examen IRM cardiaque
- d) Un CT du thorax injecté (angio-CT)
- e) Une scintigraphie pulmonaire



Un angio-CT thoracique a été réalisé

Quel est votre diagnostic ?

- a) Dissection aortique
- b) Pneumonie droite
- c) Embolie pulmonaire
- d) Tumeur pulmonaire

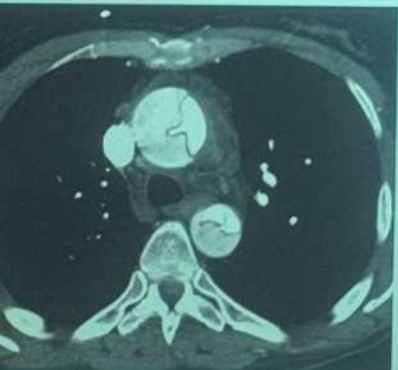




Un CT thoraco-abdominal natif et injecté a été réalisé

Quel est votre diagnostic

- a) Embolie pulmonaire
- b) Dissection aortique type B
- c) Tumeur médiastinale
- d) Dissection aortique type A

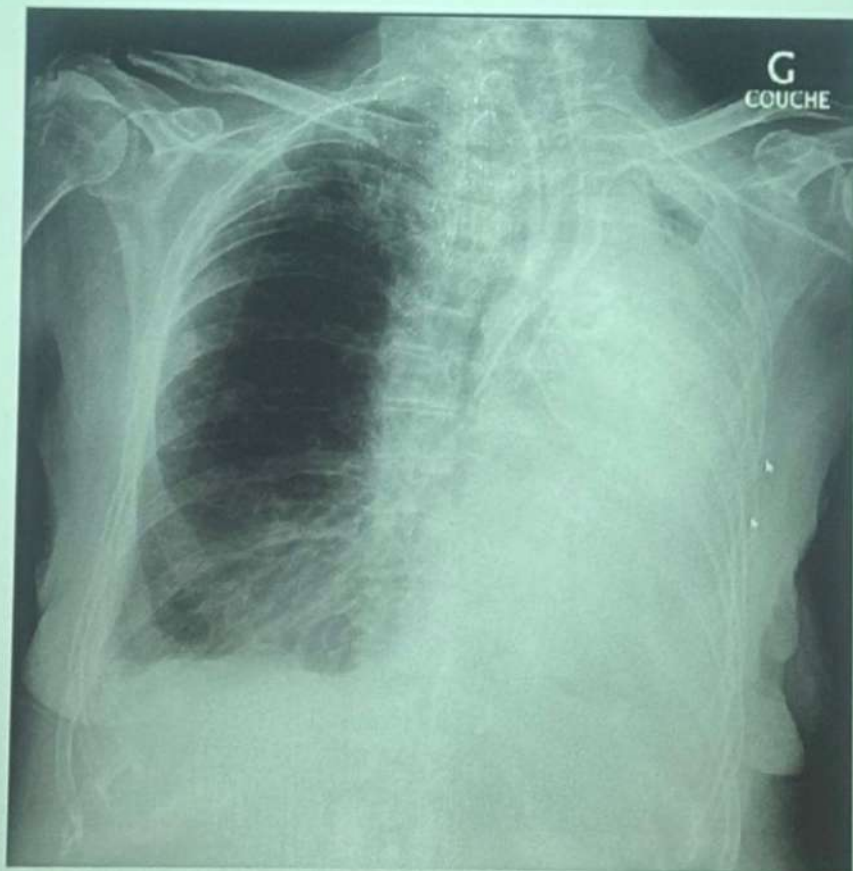


74 ans, hypertendu, douleurs thoraciques intenses, dyspnée

Quel examen d'imagerie en urgence?

- a) radiographie du thorax
- b) CT thorax natif
- c) IRM thorax
- d) CT thoraco-abdominal injecté
- e) CT thoraco-abdominal natif + injecté

Atélectasie complète du poumon gauche



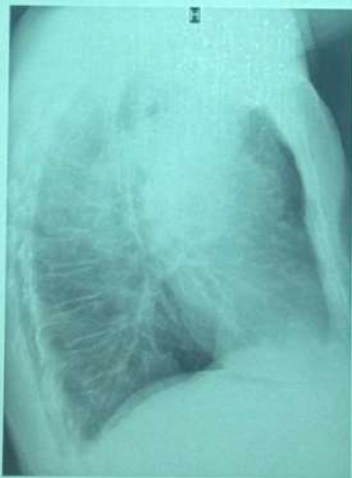
Dyspnée, baisse de l'état général



Le diagnostic le plus probable est:

- a) Pneumonie lobaire supérieure gauche
- b) Atélectasie du lobe moyen
- c) Atélectasie du lobe supérieur gauche
- d) Pneumothorax gauche

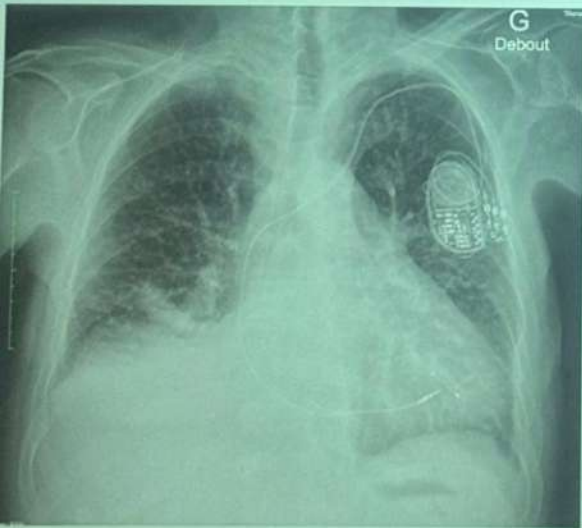
Baisse de l'état général, syndrome inflammatoire



L'opacité se situe :

- a) Poumon droit
- b) Médiastin
- c) Péricarde
- d) Artère pulmonaire droite

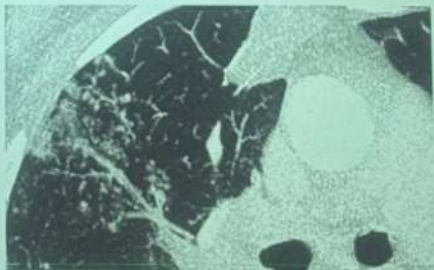
Dyspnée, orthopnée



Quel est le diagnostic le plus probable?

- a) Pneumothorax gauche
- b) Pneumonie basale droite
- c) Décompensation cardiaque
- d) Mésothéliome pleural

Examen CT



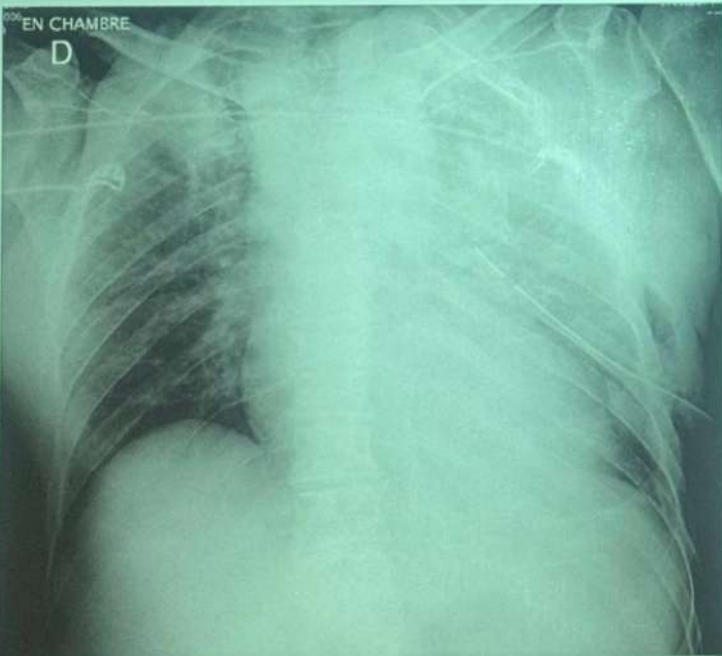
52 ans, toux productive, traitement antibiotique avec persistance de la toux



L'anomalie est représentée par :

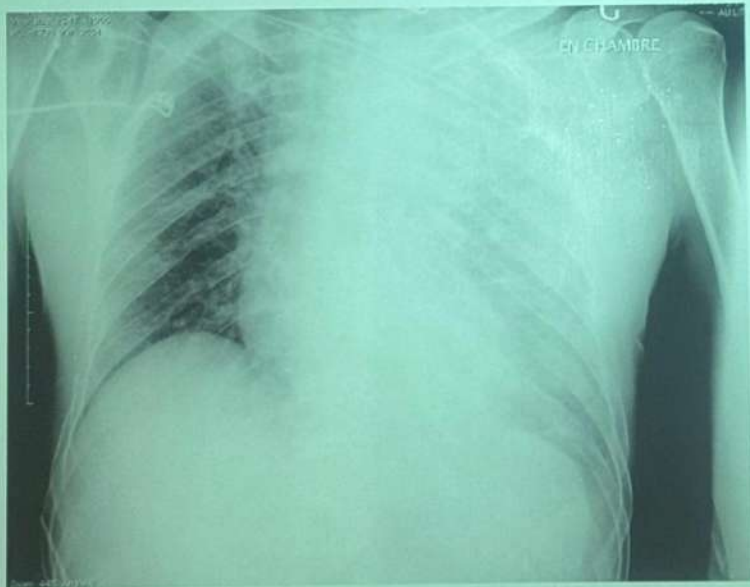
- a) Adénopathies hilaires et médiastinales
- b) Infiltrat pulmonaire droit
- c) Infiltrat pulmonaire gauche
- d) Radiographie normale

Après drainage: y-a-t-il toujours une lésion à potentiel vital?



- a) hemothorax
- b) pneumothorax
- c) fracture des côtes
- d) hémomédiastin
- e) fracture de l'omoplate

Accident de vélo, choc frontal à 50km/h avec un poteau



Conscient à l'admission, GCS = 15,

Fréquence cardiaque: 80/min

Dyspnée, TA = normal

Voies Biliaires

Quelle est la meilleure méthode pour diagnostiquer, en urgence, les calculs biliaires:

- a) CT
- b) IRM
- c) Echographie
- d) Radiographie de l'abdomen

Quels sont les signes échographiques les plus sensibles pour la cholécystite aiguë ?

- a) Lithiase vésiculaire + sludge intravésiculaire
- b) Lithiase vésiculaire + distension de la vésicule
- c) Lithiase vésiculaire + épaissement de sa paroi + signe de Murphy échographique
- d) Lithiase vésiculaire + infiltration liquidienne péri-vésiculaire

Homme, 57 ans. Douleurs fosse iliaque gauche intenses, constipation, fièvre

Quel est le diagnostic le plus probable:

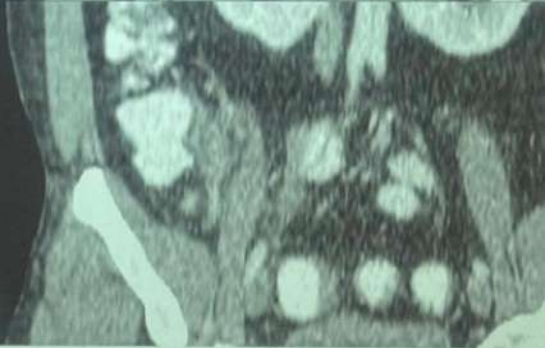
- a) Diverticulite compliquée
- b) Maladie de Crohn
- c) Intussusception
- d) Tumeur colique
- e) Volvulus du sigmoïde

Douleurs épigastriques intenses

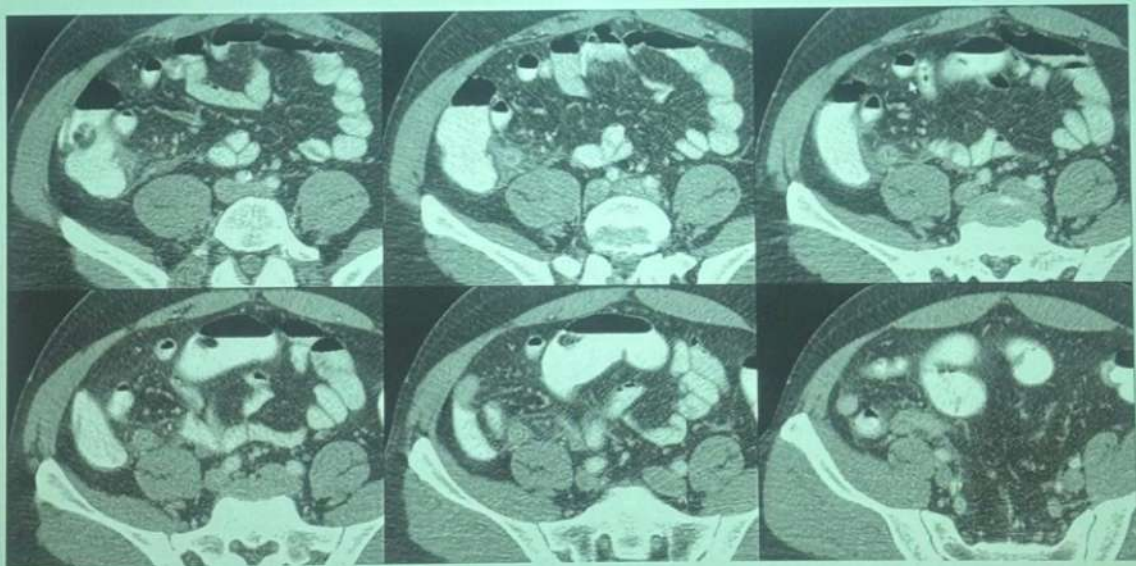


Quel est votre diagnostic?

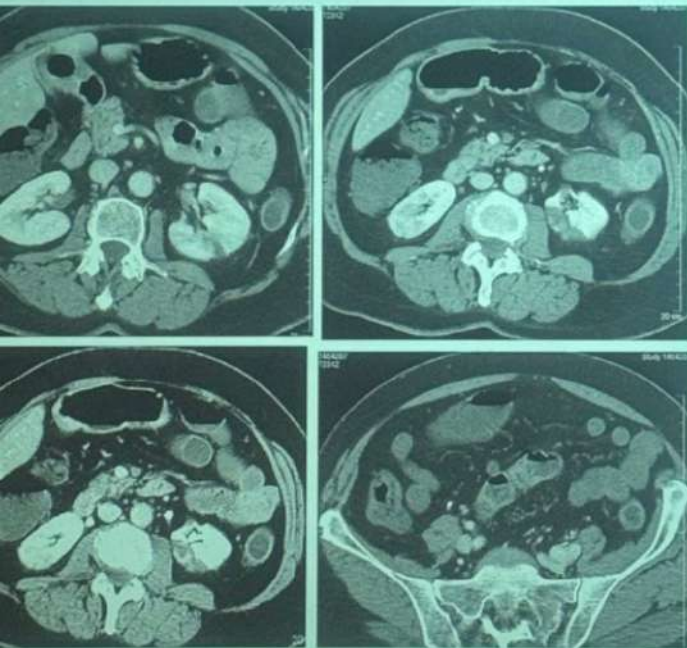
- a) Tumeur du pancréas
- b) Pancréatite œdémateuse
- c) Pancréatite nécrotique
- d) Tumeur gastrique



Douleur quadrant inférieur droit. Nausées. Diarrhées. Température 38°.



Patient 69 ans, douleurs abdominales diffuses aiguës, intenses



Le problème principal est:

- a) Pancréatique
- b) Rénal
- c) Intestinal
- d) Artériel
- e) Veineux